PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN: REINTEGRACIÓN DE SUTURAS ETHICON (JOHNSON & JOHNSON) AL SISTEMA PÚBLICO NACIONAL DE SALUD

Dirigido a: Gerencia Comercial y Asuntos Gubernamentales, Johnson & Johnson Venezuela **Fecha:** Junio 2026

Objetivo: Establecer la hoja de ruta estratégica para el reposicionamiento y la adjudicación de suturas quirúrgicas Ethicon en Hospitales Tipo III y IV a nivel nacional, superando las barreras de adjudicación basadas en el costo unitario de adquisición.

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan estratégico aborda la actual dinámica de adquisición de insumos quirúrgicos en el sistema público de salud venezolano. Actualmente, las adjudicaciones centralizadas (CORPOVEX, IVSS, Ministerio del Poder Popular para la Salud) se rigen primordialmente por el criterio del precio unitario más bajo. Esto ha favorecido la penetración de marcas asiáticas (por ejemplo, WEGO Medical / Shandong Weigao Group) que compiten ofreciendo imitaciones directas de los códigos de catálogo de Ethicon.

Esta migración hacia alternativas de bajo costo ha generado un impacto negativo documentado en las tasas de morbilidad postoperatoria, específicamente en el incremento de Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ) y dehiscencias, lo que a su vez se traduce en una estancia hospitalaria prolongada. El plan de acción propone una estrategia integral basada en el "Bottom-Up" (generación de demanda técnica desde el quirófano hacia la gerencia administrativa), estructurada en cuatro pilares: Reposicionamiento, Calidad (Eficiencia Tecnológica), Factor Gobierno (Gestión Institucional) y Precios (Análisis de Retorno de Inversión Hospitalario).

2. PILAR DE REPOSICIONAMIENTO: Capitalización de la "Estandarización de Códigos"

Análisis de la Situación Actual: El mercado venezolano evidencia un fenómeno donde competidores directos (fabricantes chinos bajo la modalidad OEM o marca propia) comercializan suturas utilizando una nomenclatura que imita el catálogo histórico de Ethicon. Por ejemplo, el código 811 de Ethicon se comercializa bajo la competencia como 811-1. Esto confirma que el estándar de referencia técnica, la especificación solicitada por

el cirujano y la necesidad real del mercado sigue siendo el producto diseñado por Johnson & Johnson.

Acciones Estratégicas:

1. **Campaña de Reconocimiento del "Estándar Original":**
    - **Acción:** Desarrollar material técnico-comercial dirigido a Jefes de Servicio (Cirugía General, Ginecología y Traumatología) que evidencie que la solicitud de códigos específicos en las licitaciones responde a las características metalúrgicas y de polímeros exclusivas de Ethicon, las cuales no pueden ser replicadas simplemente copiando el número de catálogo.
    - **Mensaje Clave:** "El código es Ethicon. El resultado clínico debe ser Ethicon."
2. **Educación Médica Continua (Estandarización Quirúrgica):**
    - **Acción:** Reactivar los programas de formación para residentes de posgrado, enfatizando que la técnica quirúrgica estándar que aprenden requiere de la predictibilidad que ofrecen los materiales originales. La variación en la memoria elástica o en el filo de la aguja de los productos clonados introduce variables de riesgo no controladas en el quirófano.

3. PILAR DE CALIDAD: Impacto Clínico y Eficiencia en la Rotación de Camas

Análisis de la Situación Actual: La métrica crítica de desempeño en los Hospitales Tipo III y IV de Venezuela no es el número de cirugías realizadas, sino la disponibilidad de camas operativas. Los reportes clínicos evidencian que el uso de suturas con baja calidad en la aleación de la aguja (pérdida de filo tras múltiples pases) y en el recubrimiento del hilo (efecto sierra, isquemia y necrosis) desencadenan Infecciones del Sitio Quirúrgico (ISQ). Una ISQ prolonga la estancia hospitalaria en un promedio de 9.7 días adicionales.

Acciones Estratégicas:

1. **Posicionamiento de Tecnologías Avanzadas como Solución Epidemiológica:**
    - **Acción:** Introducir en la promoción institucional las tecnologías de alto desempeño de Ethicon: aleaciones *Everpoint* y *Prime* para agujas (reducción del trauma tisular) y la línea de suturas *Plus* (recubrimiento con Triclosán).
    - **Evidencia a Presentar:** Demostrar estadísticamente cómo la tecnología *Plus* ha demostrado reducir el riesgo de ISQ hasta en un 28%. El argumento debe pivotar de "vender suturas" a "proveer una herramienta para el control de infecciones nosocomiales".
2. **Métrica de "Camas Liberadas":**
    - **Acción:** Presentar a las direcciones médicas el impacto de la tecnología en la tasa de rotación. La reducción de complicaciones (dehiscencias e infecciones) permite el alta temprana del paciente, liberando camas críticas para atender la lista de espera quirúrgica nacional y disminuyendo el colapso de las áreas de hospitalización.

4. PILAR FACTOR GOBIERNO: Estrategia "Bottom-Up" y Blindaje Legal-Administrativo

Análisis de la Situación Actual: Las compras centralizadas (Ministerio de Salud, IVSS, CORPOVEX) operan bajo matrices de evaluación financiera estrictas. Las adjudicaciones a marcas transnacionales requieren de una justificación técnica imperativa que exceda el simple análisis de precio unitario. La demanda no puede generarse "Top-Down" (desde el Ministerio hacia el Hospital), sino que debe construirse desde el quirófano hacia la gerencia central.

Acciones Estratégicas:

1. **Implementación de Hojas de Evaluación de Producto (Trial Programs):**
    - **Acción:** Introducir lotes de prueba controlados en hospitales clave (ej. Hospital Miguel Pérez Carreño, Maternidad Concepción Palacios, Hospital Universitario de Caracas). Distribuir hojas de evaluación estandarizadas para que los cirujanos documenten parámetros específicos: penetración tisular, seguridad del nudo, arrastre capilar y tasas de complicación postoperatoria temprana.
    - **Objetivo:** Generar data clínica local y reciente que contraste el desempeño de la sutura original (Ethicon) versus la sutura clonada (ej. códigos "-1").
2. **Gestión de Cartas de Exposición de Motivos (Justificación de Excepción):**
    - **Acción:** Utilizar la data recolectada en las hojas de evaluación para redactar Cartas de Exposición de Motivos en conjunto con los Directores de Hospitales y Jefes de Servicio.
    - **Objetivo Legal:** Estos documentos, firmados por las máximas autoridades médicas de las instituciones, constituyen el sustento legal y técnico necesario para que el ente centralizador justifique una adjudicación directa o por vía de excepción a favor de Ethicon, escudándose en la "necesidad médica irrefutable y la protección de la vida del paciente".

5. PILAR DE PRECIOS: Transición del "Costo Unitario" al "Costo Total del Tratamiento" (Retorno de Inversión)

Análisis de la Situación Actual: La competencia asiática presenta ventajas de precio de adquisición que oscilan entre un 30% y un 50% por debajo de los precios de Ethicon. En el contexto de presupuestos deficitarios, la defensa del producto basada únicamente en atributos de calidad es insuficiente frente a las comisiones de licitación.

Acciones Estratégicas:

1. **Análisis de Costo-Consecuencia (El Costo Oculto de la Baja Calidad):**

- **Acción:** Desarrollar e implementar en las presentaciones de venta un modelo financiero adaptado a la realidad hospitalaria venezolana. Se debe cuantificar el costo real de una Infección del Sitio Quirúrgico (ISQ).
- **Argumento Financiero:** Demostrar que el ahorro inicial logrado al comprar una caja de suturas de bajo costo se anula y revierte cuando se contabiliza:
  - El costo de 9.7 días adicionales de hospitalización.
  - El costo de los esquemas de antibióticos de amplio espectro (suministrados por el Estado).
  - El costo de curas complejas diarias, horas de personal de enfermería y posibles re-intervenciones quirúrgicas en quirófano.

2. **El ROI de Ethicon como Póliza de Seguro Presupuestario:**
   - **Acción:** Posicionar el diferencial de precio de Ethicon no como un sobreprecio, sino como una prima de seguro de responsabilidad hospitalaria. La inversión marginal requerida para adquirir tecnología Ethicon asegura un Retorno de Inversión (ROI) inmediato al prevenir la cascada de gastos asociados a las complicaciones postoperatorias, optimizando así la ejecución del escaso presupuesto público asignado a cada institución.